

Cztery fazy *powrotu*

Wypalenie kliniczne nie cofa się tygodniem urlopu. Strukturalny plan, mierzalne kryteria przejścia, realistyczny horyzont.

CZAS: 20 min sporządzenia planu **HORYZONT:** 3-6 miesięcy

ŹRÓDŁO: Joyce i in. (2016, Cochrane); Hatch i in. (2019, przegląd *return to work*); Maslach & Leiter (2016)

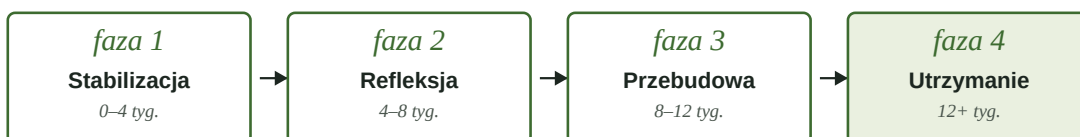
JAK UŻYWAĆ

Plan czterofazowy: **stabilizacja** (0-4 tyg.), **refleksja** (4-8 tyg.), **przebudowa** (8-12 tyg.), **utrzymanie** (od 12 tyg.). Każda faza ma *cel*, *czego nie robić* i *kryteria przejścia* do następnej (sekcja 01). W sekcji 02 zapisujesz swoje konkretne treści dla każdej fazy. Sekcja 03 — kryteria gotowości do powrotu, których nie pomijasz. Plan jest pisemny, dostępny, przeglądany co 2 tygodnie z prowadzącym terapeutą lub lekarzem medycyny pracy.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Joyce i in. (2016, przegląd Cochrane interwencji dla pracowników z problemami zdrowia psychicznego): **strukturyzowane interwencje** łączące pracę poznawczo-behawioralną z modyfikacją warunków pracy są skuteczniejsze niż sam odpoczynek — i istotnie zmniejszają nawroty. Hatch i in. (2019, przegląd badań nad *return to work* po wypaleniu): stopniowy, planowany powrót do pracy wiąże się z mniejszym ryzykiem ponownego zwolnienia chorobowego niż powrót nagły. Maslach i Leiter (2016) podkreślają, że bez zmiany *systemu*, w którym wypalenie powstało, powrót zwykle prowadzi do nawrotu w ciągu 6-18 miesięcy. Plan czterofazowy jest narzędziem klinicznym: każda faza ma odmienne zadania i odmienne kryteria sukcesu, a horyzont 3-6 miesięcy odpowiada realnemu tempu regulacji osi HPA i normalizacji funkcjonowania.

01 Cztery fazy — schemat



FAZA 1 · STABILIZACJA (0-4 TYG.)

Cel: sen, jedzenie, ruch, zerowanie. Minimum obowiązków. *Żadnych dużych decyzji.*

Nie: zmiana pracy, rozmowa z szefem, planowanie przyszłości.

Przejście: sen ≥ 7 h przez 7 dni, podstawowe samoobsługa stabilna.

FAZA 2 · REFLEKSJA (4-8 TYG.)

Cel: co spowodowało wypalenie — model JD-R, wartości, granice. *Co musi się zmienić, żeby nie wrócić.*

Nie: samobiczowanie, nadmierna „praca nad sobą”.

Przejście: jasna mapa przyczyn, lista konkretnych zmian do wprowadzenia.

FAZA 3 · PRZEBUDOWA (8-12 TYG.)

Cel: wdrożenie zmian — granice, komunikacja, przerwy, wsparcie. Rozmowa z przełożonym. *Job crafting*, jeśli to możliwe.

Nie: próby od razu pełnego tempa pracy.

Przejście: co najmniej 2 zmiany wdrożone i stabilne.

FAZA 4 · UTRZYMANIE (12+ TYG.)

Cel: monitorowanie (jeden krótki kwestionariusz raz w miesiącu). *Plan B* na wypadek nawrotu. Superwizja lub coaching.

Nie: uznanie, że problem „się rozwiązał”.

Sygnał alarmowy: dwa wskaźniki ze zwykłą → wróć do fazy 2 lub 3.

02 Twój plan — cztery fazy konkretnie

Dla każdej fazy zapisz: **jeden cel, jedno wsparcie** (osoba, terapeuta, lekarz), **jedno kryterium przejścia** do następnej fazy. Konkretnie, mierzalnie, z datą.

FAZA 1 • STABILIZACJA

— mój cel, moje wsparcie, kryterium przejścia

FAZA 2 • REFLEKSJA

— mój cel, moje wsparcie, kryterium przejścia

FAZA 3 • PRZEBUDOWA

— mój cel, moje wsparcie, kryterium przejścia

FAZA 4 • UTRZYMANIE

— mój cel, moje wsparcie, sygnały alarmowe

03 Kryteria gotowości do powrotu

Pięć warunków. Każdy **musi** być spełniony przed pełnym powrotem do pracy. Powrót przed gotowością to wysokie ryzyko gorszego nawrotu.

 **Energia $\geq 7/10$** przez 2 tygodnie z rzędu (pomiar wieczorny).

 **Sen stabilny ≥ 7 h**, bez budzenia w nocy z myślami o pracy.

 **Brak ruminacji** — myśli o pracy w czasie wolnym < 30 min dziennie.

 **Sens odzyskany** — potrafię odpowiedzieć, po co wracam.

 **Plan po powrocie** — ustalone granice, godziny pracy, pierwsza miesięczna superwizja lub konsultacja, plan reakcji na ewentualny nawrót.

Klucz: regeneracja z klinicznego wypalenia zawodowego trwa **miesiące, nie tygodnie**. Hatch i in. (2019): średni czas pełnego powrotu po wypaleniu wymagającym zwolnienia lekarskiego to 3–6 miesięcy, a u około 1/3 osób nawrót następuje w pierwszym roku — głównie przy powrocie do *tych samych* warunków pracy. Plan czterofazowy jest pisemny i przeglądany regularnie z prowadzącym terapeutą lub lekarzem medycyny pracy. Bez systematyki regeneracja jest podatna na powrót presji wynikowej.